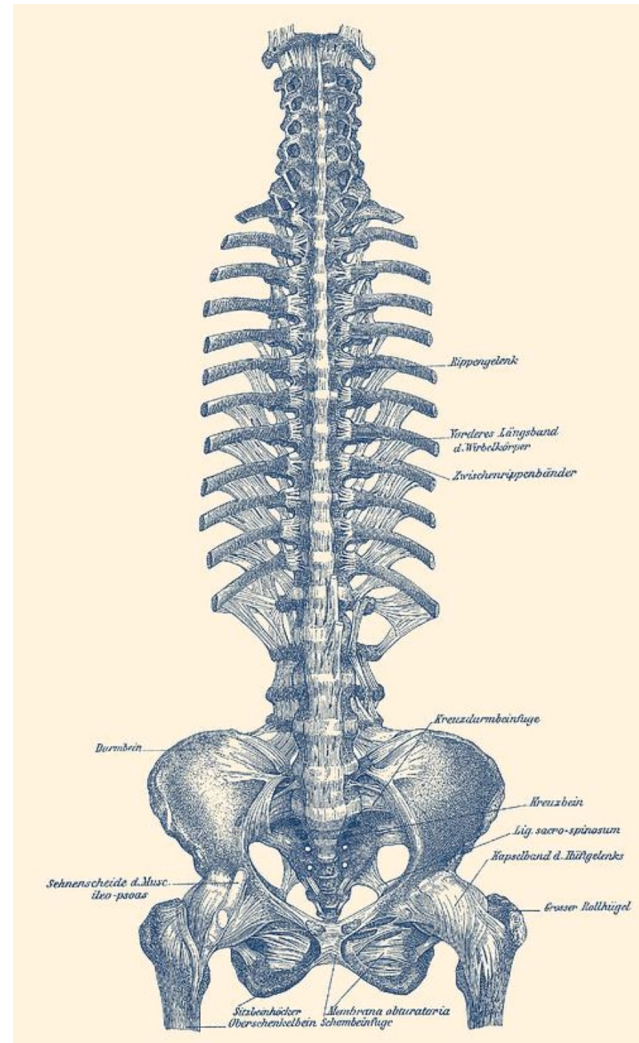


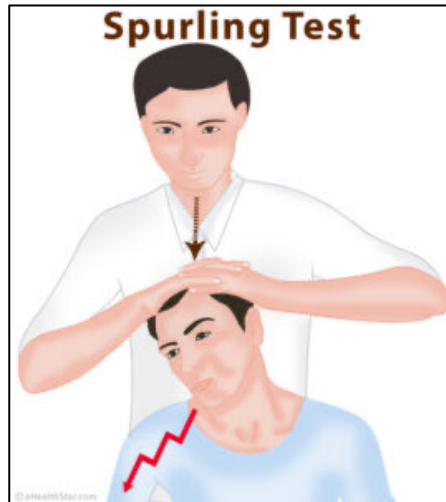
Rachis : Rappel des test spécifiques et pathologies courantes



Rachis : Rappel des test spécifiques

Cervicalgie : Test de Spurling

- Pour mettre en évidence une radiculopathie cervicale
- Cave : Dermatome pour l'irradiation de la douleur dans le MS
 - [C4-C5] → **C5** : Épaule
 - [C5-C6] → **C6** : Face latérale du bras, de l'avant-bras et de la main (pouce)
 - [C6-C7] → **C7** : Face dorsale de la main, doigts 2-3-4
 - [C7-C8] → **C8** : Face médiale du bras, de l'avant-bras et de la main, doigts 5

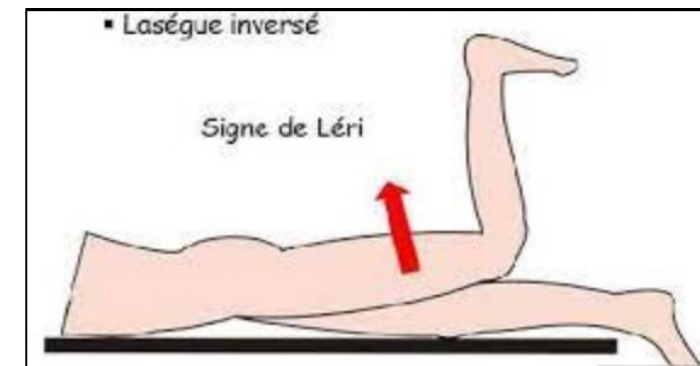
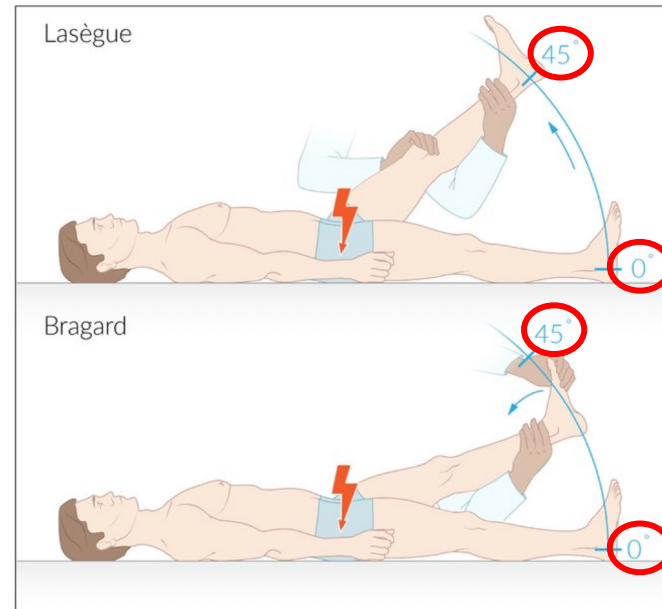


Lombalgie : Test de Lasègue-Bragard

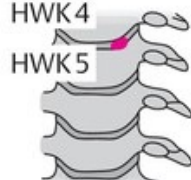
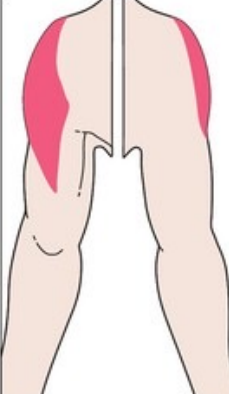
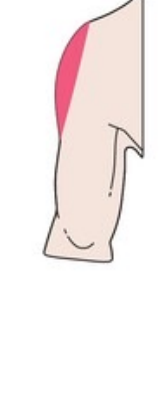
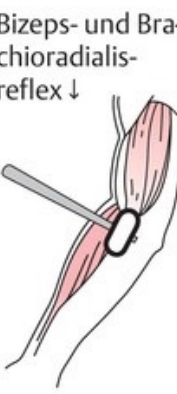
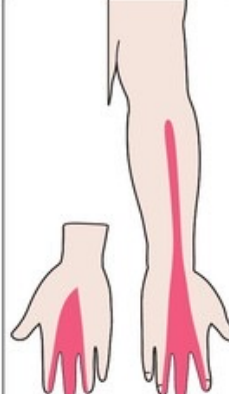
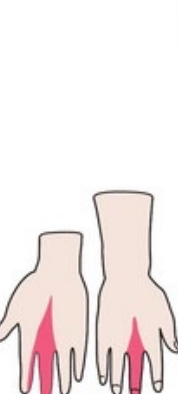
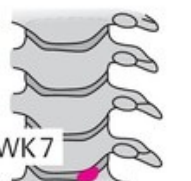
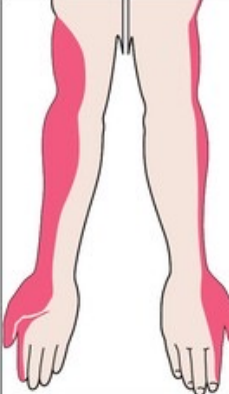
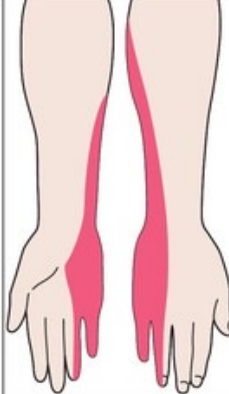
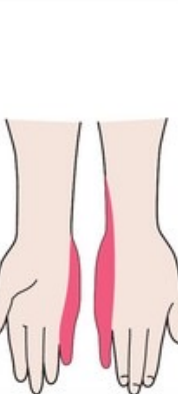
- Pour mettre en évidence une radiculopathie lombaire (N. sciatique, niveaux **L4-S1**)
- Cave : Dermatome pour l'irradiation de la douleur dans le MI
 - [L2-L3] → **L3** : Partie latérale cuisse jusqu'à la partie médiale sous le genou
 - [L3-L4] → **L4** : Partie latérale cuisse jusqu'à la partie médiale du pieds (orteil 1-2)
 - [L4-L5] → **L5** : Partie latérale cuisse jusqu'à la partie intermédiaire du pieds (orteil 3-4)
 - [L5-L6] → **S1** : Partie postérieure de la cuisse et de la jambe, partie latérale du pied (orteil 5)

Lombalgie : Test de Lasègue inversé

- Pour mettre en évidence une radiculopathie lombaire (N. fémoral, niveaux **L2-L4**)
- Cave : Dermatome pour l'irradiation de la douleur dans le MI
 - [L2-L3] → **L3** : Partie latérale cuisse jusqu'à la partie médiale sous le genou
 - [L3-L4] → **L4** : Partie latérale cuisse jusqu'à la partie médiale du pieds (orteil 1-2)



Racine	Dermatome	Motricité		Réflexes	Tension radiculaire
L3		Ilio-psoas Quadriceps	• Flexion de la cuisse au niveau de la hanche • Flexion du tronc en avant • Rotation externe de la cuisse • Extension de la cuisse au niveau du genou	Rotulien diminué → absent	Signe de Thomas Signe de Léri
		➤ limitation pour étendre la jambe et se lever d'une chaise (signe du tabouret)			
L4		Quadriceps Tibial antérieur	• Extension de la cuisse au niveau du genou • Flexion dorsale du pied • Inversion du pied	Rotulien diminué → absent	Signe de Thomas Signe de Léri Signe de Lasègue
		➤ limitation pour étendre la jambe, s'accroupir, se lever, monter les escaliers et marcher sur les talons			
L5		Tibial antérieur Extenseur orteil Péronniers latéraux	• Flexion dorsale du pied • Inversion du pied • Flexion dorsale du pied • Inversion du pied • Eversion du pied	Réflexes intacts	Signe de Lasègue
		➤ steppage et limitation de la marche sur les talons, instabilité de la cheville en marchant sur les pointes			
S1		Triceps sural Biceps fémoral Grand fessier	• Flexion plantaire du pied • Flexion de la jambe au niveau du genou • Soulève le talon lors de la marche • Flexion de la jambe au niveau du genou • Rotation latérale du tibia (genou fléchi) • Extension et rotation latérale de la cuisse	Achilléen diminué → absent	Signe de Lasègue
		➤ limitation de la marche sur la pointe des pieds			

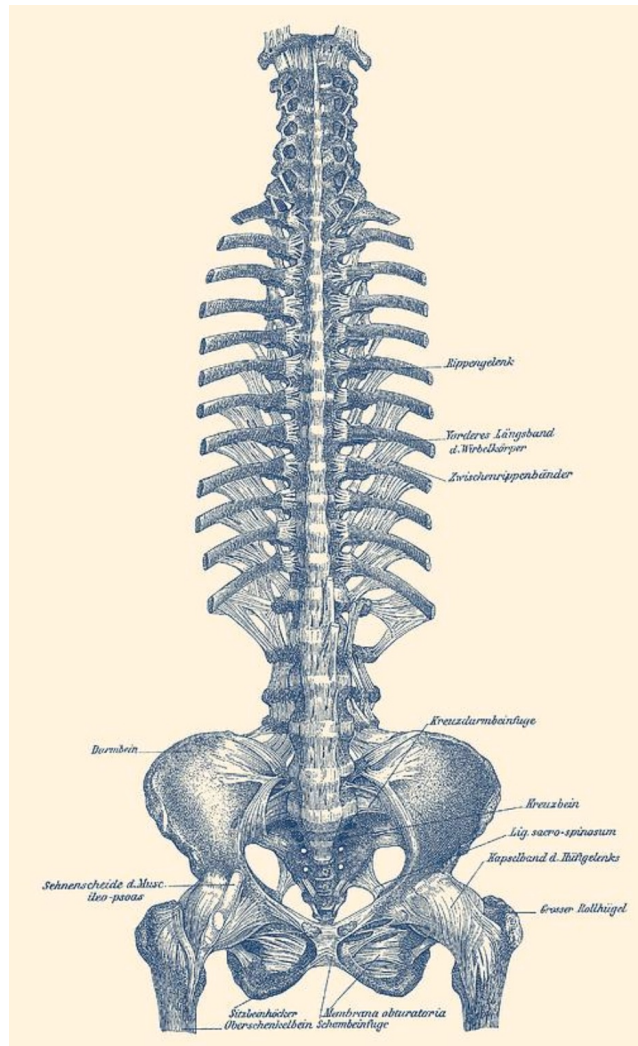
 HWK 4 HWK 5	C5				 HWK 6 HWK 7	C7			
Schmerzen	Hypästhesie	Paresen	Armreflexe	Schmerzen	Hypästhesie	Paresen	Armreflexe		
		M. deltoideus 	Bizeps- und Brachioradialis-reflex ↓ 			M. triceps brachii 	Trizeps-reflex ↓ 		
 HWK 5 HWK 6	C6				 HWK 7	C8			
Schmerzen	Hypästhesie	Paresen	Armreflexe	Schmerzen	Hypästhesie	Paresen	Armreflexe		
		Mm. biceps brachii et brachioradialis 	Bizeps- und Brachioradialis-reflex ↓ 			Hand-muskeln 	Trömner-Reflex ↓ 		

Rachis : Rappel des test spécifiques

Sacro-illite : Test de Mennel (3-phase test)

- Pour distinguer une sacro-illite d'une atteinte du rachis lombaire et de l'articulation de la hanche
- Effectuer une extension passive de la cuisse tout en pressant sur le rachis lombaire, puis l'articulation sacro-iliaque et enfin sur l'articulation de la hanche





Maladie dégénérative des disques intervertébraux et du rachis :

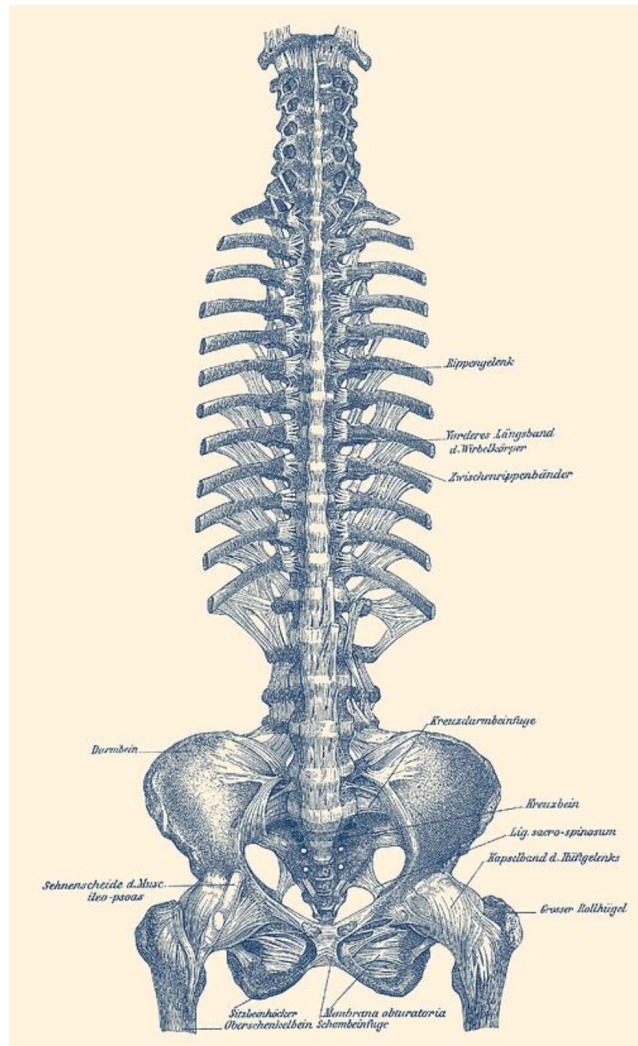
- **Définition :** Groupe de pathologie où le contenu du disque est déplacé en regard du canal rachidien, provoquant des protrusions, des herniations ou des séquestrations discales. Elles peuvent être asymptomatiques ou provoquer des radiculopathies (irritatives ou déficitaires) et des myélopathies. Plus de 50% de la population adulte se plaint de maux de dos, mais < 5% sont causés par des hernies discales. Les niveaux les plus fréquemment touchés L5-S1 puis L4-L5
- **Cliniques:**
Syndrome rachidien (cervicalgie, lombalgie) plus **syndrome radiculaire** (irritatif ou déficitaire).
 En fonction de la hauteur, les cliniques seront différentes suivant les dermatomes et les myotomes.
 Les symptômes peuvent être déclenchés par des manœuvres de provocation (**Spurling, Lasegue, Bragard**).
 Un syndrome radiculaire est dit déficitaire en cas de diminution de la force et de la sensibilité de la zone innervée.
 En cas de simples douleurs irradiant dans le dermatome, on parle de syndrome radiculaire irritatif.
- **Red flag :**
 Durée **> 6 semaines** malgré un traitement conservateur bien conduit
 Âge : **<18 ans** ou **>50 ans**
Post-traumatisme ou **douleur localisée à la palpation**
Ostéoporose connue ou après **longue corticothérapie**,
Cancer connu (même si considéré en rémission depuis des années)
Symptôme B, douleurs nocturnes
IVDU, Immunosuppression, infection ou opération récente
 Douleurs empirant lors des **manœuvre de Valsalva**
Déficit neurologique (sensoriel, moteur, incontinence, anesthésie en selle, impotence...)
- **Diagnostic:**
 - En absence de red-flag : diagnostic uniquement clinique
 - En présence de red-flag : Imagerie (**IRM en urgence**, éventuellement myélographie CT si IRM indisponible)
- **Traitement :**
 - En absence de red-flag : absence de lésion sous-jacente, amélioration en 2-3 semaines. Réassurance, consultation de contrôle à 1-2 semaines. Antalgie par **AINS** (ibuprofène) ± **monodose de DXM**.
 Pas d'association AINS + Paracétamol, pas d'opioïde plus de 5 jours, pas d'antiépileptique
 - En présence de red-flag : Traitement en fonction de la cause (fracture, métastase, abcès...)

T2 : Hernie C5-C6



T2 : Hernie L5-S1





Spondylolisthésis:

- **Définition :** Glissement vertébral antérieur (fréquent, antérolisthésis) ou postérieur (rare, rétrolisthésis). Touche environ 10% de la population générale. Les deux formes les plus fréquentes sont les spondyloesthésis **type II (isthmique)** et **type III (dégénératives)**.
Le type II touche de façon prédominante le niveau L5-S1, le type III le niveau L4-L5.
 - Type II : Patient jeune, après des traumatismes mineurs mais répétés entraînant des glissements vertébraux
 - Type III : Patient âgé de >60 ans avec de l'arthrose. Touche 6x plus les femmes que les hommes
- **Cliniques:** Volontiers asymptomatiques (majorité des patients), surtout lors d'un glissement sur une surface <50%. En cas de symptomatologie, on trouve fréquemment des syndromes rachidiens (lombalgie) parfois accompagné d'un syndrome radiculaire (irritatif ou déficitaire).
- **Diagnostic:** Le diagnostic nécessite une imagerie (simple radio de profil).
En cas de red-flag pour une atteinte nerveuse, aller à l'IRM.
- **Traitement :** En général un traitement conservateur produit des bons résultats surtout si glissement < 50%.
En dernière intention, on peut effectuer une opération neurochirurgicale (fusion vertébrale).

L4-L5, grade I (< 25%)



L4-L5, grade II (25-50%)

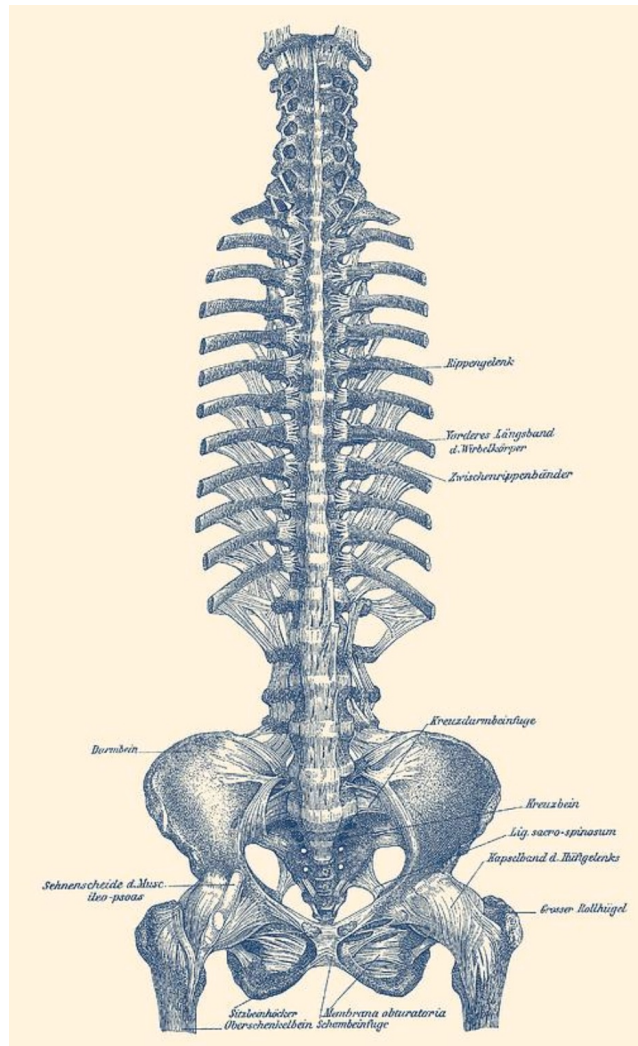


L4-L5, grade III (50-75%)



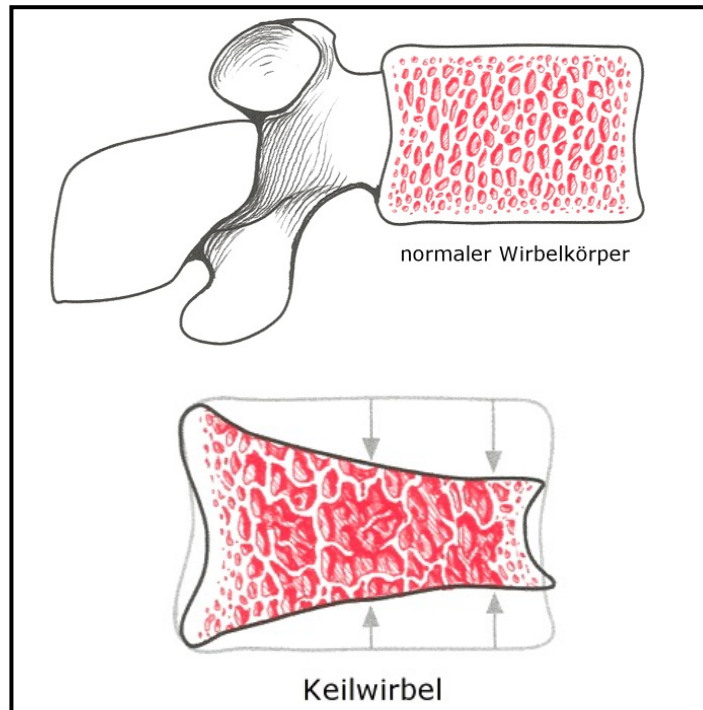
L5-S1, grade IV (>75%)





Fracture vertébrale ostéoporotique :

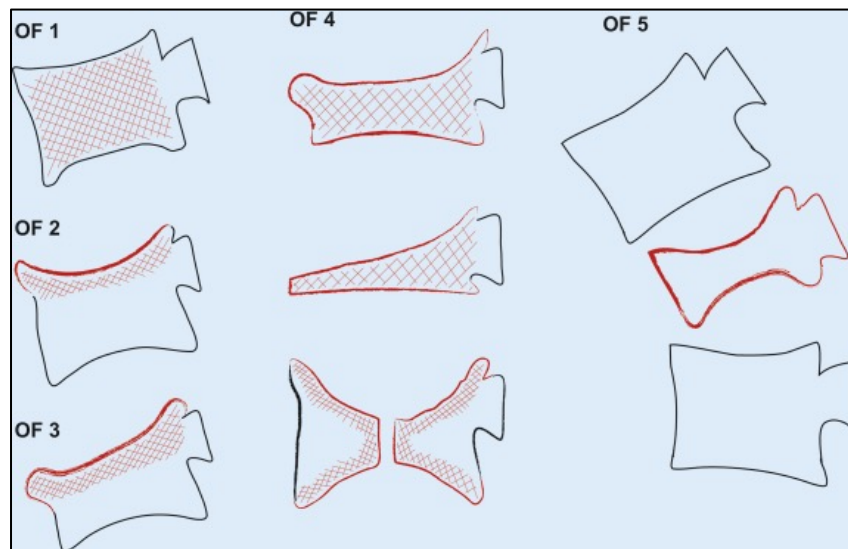
- **Définition :** L'ostéoporose est la cause de la grande majorité des fractures vertébrale par compression. Elles surviennent volontiers après un stress mineur (chute, flexion soudaine, soulèvement d'une charge, toux).
- **Cliniques:** Parfois asymptomatique, se manifestant uniquement par un tassement. Autrement, douleur dorsale reproductible à la palpation de la vertèbre touchée.
- **Diagnostic:** Chercher une ostéoporose (DXA scan) et mettre en évidence une fracture avec une forme typique en triangle (keilwirbel) à la radiographie ou au CT
- **Traitement :** En général, l'antalgie et la mobilisation précoce sont suffisantes. L'ostéoporose sous-jacente doit-être traitée (*biphosphonate, vitamine D, calcium, renforcement musculaire*). Si nécessaire, une kyphoplastie au ballon peut-être effectuée.

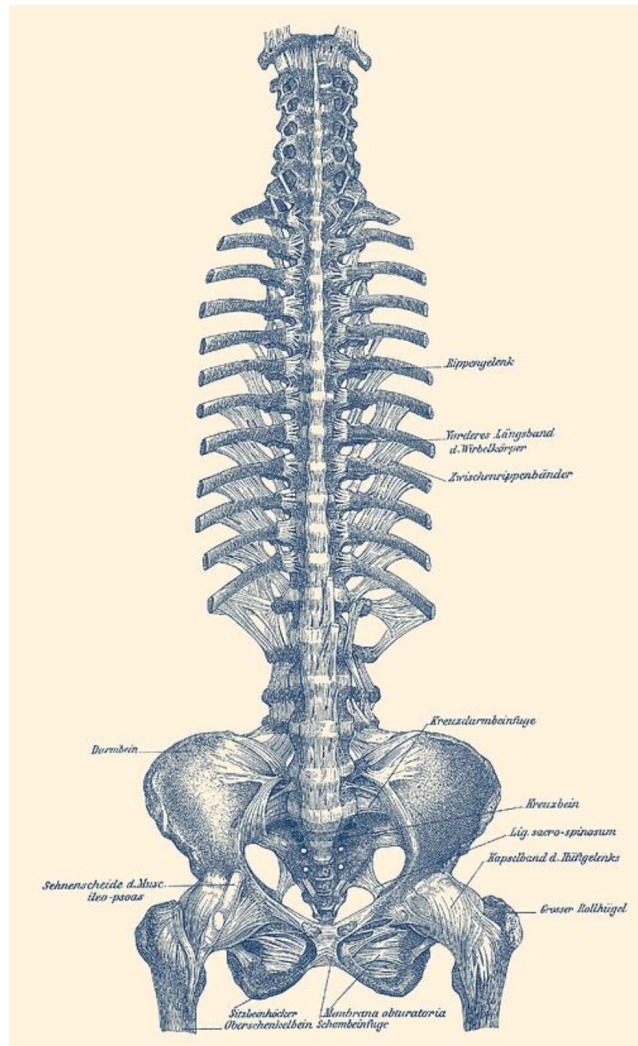


**Aspect typique d'une fracture
ostéoporotique par compression**



**Fracture ostéoporotique
aux niveaux T8 et T10**





Spondylarthrite ankylosante (M. Bechterew) :

- **Définition :** Maladie inflammatoire chronique séronégative, touchant le squelette axial et conduisant à la rigidification de la colonne et la fusion des vertèbres. Typiquement, la maladie commence par une érosion au niveau de l'articulation sacro-iliaque, puis progresse avec la formation de syndesmophytes puis leur fusion. Les hommes sont 3x plus atteints par la maladie, et >90% possèdent le HLA-B27. Le pic d'incidence est entre 20-40 ans. La maladie peut-également se manifester par des atteintes extra-articulaires.
- **Cliniques:** Douleurs nocturnes, soulagées par la prise d'AINS accompagné de rigidité matinale. Autres symptômes : dactylite (DD arthrite psoriasique), enthésite, uvéite antérieure, dyspnée sur syndrome restrictif (diminution mobilité vertèbres thoracique et des côtes).
Signe de Mennel (sacroiliite), diminution de la mobilité vertébrale (**ampliation thoracique**, inclinaisons latérales).
- **Diagnostic:** L'IRM permet un diagnostic plus précoce, notamment pour chercher une sacroiliite. Les syndesmophytes sont visibles au CT et sur une radio standard. La VS et la CRP sont augmentés et le HLA-B27 est positif tandis que les anticorps pour d'autres maladies rhumatismale (ANA, ANCA, anti-CCP, FR) sont négatifs.
- **Traitement :** AINS en première ligne, si nécessaire anti-TNFα.

«Bamboo spine »



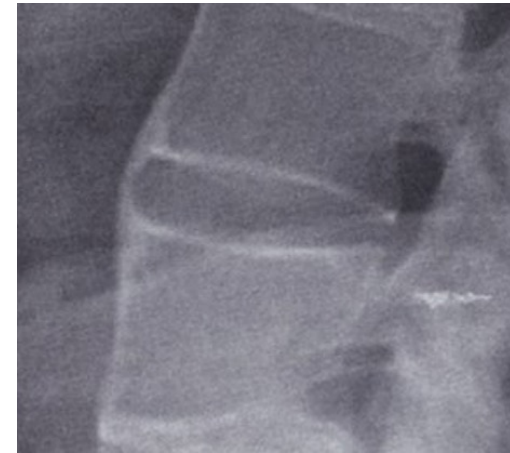
«Bamboo spine »



Syndesmophyte



Lésion de Romanus
(shiny corners)



Scaro-illite à l'IRM

